

NOTULEN

HARI / TANGGAL

: Selasa / 22 Oktober 2024

PUKUL

: 10.00-11.30 WIB

JENIS MEETING

: Rapat Komite Medik

TEMPAT

: Zoom

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Rujukan dari FKTP Masalah : Pasien rujukan dari FKTP ke Rumah sakit untuk Diagnosa yang dicantumkan padarekam medis rumah sakit adalah diagnose spesialisik (di luar 144 diagnosa FKTP) Misalnya : Rujukan dengan Bronkiolitis □ Setelah dilakukan pemeriksaan di RS, pasien di diagnosa DPJP = bronchitis (non spesialisik) Rujukan non spesialisik yang tidak bisa dirujuk ke RS diantaranya = Scabies, Myalgia, Dyspepsia, Asma (yang masuk ke dalam 144 diagnosa FKTP) Keterangan : Potensi terkena audit oleh BPJS jika diagnose rujukan tidak sesuai dengan diagnose spesialisik, jika hal tersebut terus berlangsung, maka akan berpengaruh pada proses kredensial FKTP kenapa mengeluarkan rujukan yang spesialisik tetapi di RS (FKTRL) berubah menjadi diagnose non spesialisik. (dapat dilayani di FKTP) PIC : DPJP Rencana Tindak Lanjut Jika ditemukan diagnosis yang tidak sesuai dengan diagnose rujukan , maka pasien dapat di PRBatau ditulis di surat rujuk balik nya bahwa pasien dapat dilayani di FKTP.
No	Penjelasan
2	Pokok Bahasan : Pending 2x tidak layak Masalah : Apabila ada case yang terpending hingga 2x, maka bulan depannya jika case tersebut di ulangi kembali, BPJS tidak akan mengkonfirmasi akan tetapi langsung tidak dilayakkan. Contoh: bulan September terdapat kasus GERD yang terpending, bulan oktober jika ada kasus GERD lagi (yang tidak sesuai dengan PNPK), maka potensi langsung tidak dilayakkan (tanpa konfirmasi terlebih dahulu dari BPJS) Keterangan : harus mengacu pada PNPK BPJS kesehatan meskipun RS mempunyai PPK PIC : DPJP dan tim KMKB Rencana Tindak Lanjut : Tim Fraud dan asuransi center mengkaji ulang DRM yang terpending dan yang akan dikirimkan untuk proses klaim, agar bulan selanjutnya tidak termasuk klaim pending berulang yang berpotensi tidak dilayakkan. Tim Fraud dan Asuransi centre akan tetap berkolaborasi dengan DPJP terkait diagnosa yang akan di gunakan oleh DPJP serta penulisan diagnosa oleh DPJP di lembar DRM wajib menggunakan Bahasa medis kedokteran, bukan menggunakan Bahasa coding (Tim Asuransi centre yang akan menerjemahkan ke Bahasa coding) Dibawah ini adalah contoh kasus dengan klaim yang berpotensi pending :



	- Saraf - Hemiplegia : permintaan BPJS untuk di sertakan lembar konsul kepada fisioterapi, pengkajian awal fisioterapi serta penulisan DPJP rehab medik di lembar CPPT - Hipokalsemia : di konfirmasi terkait terapi yang di berikan apakah secara PNPk cukup dengan Licocalk - Jantung - Valve Insuficiency : bisa di masukan ke dalam diagnosa HF (karena Valve Insuficiency merupakan penyebab) - Bedah - Tindakan Eksisi pada kasus STT : di konfirmasi terkait dengan ukuran dan kedalaman serta indikasi di lakukan di rawat inap → saran setiap ada case eksisi STT sebaiknya di dokumentasikan hasil eksisi dengan ukuran dan wajib di lakukan PA serta penulisan di laporan operasi untuk lebih lengkap - Bedah Plastik - KOntrol post tindakan di IGD : konfirmasi oleh BPJS terkait kontrol yang seharusnya di lakukan di Poli - Tindakan Rekonstruksi Penis : di konfirmasi oleh BPJS terkait indikasi di lakukan rekonstruksi penis, meskipun setelah konfirmasi selanjutnya di ganti dengan sirkumcisi akan di tanyakan indikasi cirkum dilakukan di ruang IKO dan di rawat inapkan - Urologi - Litotripsi berulang : di konfirmasi oleh BPJS terkait tindakan litotripsi berulang pada pasien dengan aff dj stent Tindakan - Rekonstruksi Penis : di konfirmasi oleh BPJS terkait indikasi di lakukan rekonstruksi penis, meskipun setelah konfirmasi selanjutnya di ganti dengan sirkumcisi akan di tanyakan indikasi cirkum dilakukan di ruang IKO dan di rawat inapkan - Obgyn - Biopsi : di konfirmasi terkait dilakukannya biopsy di rawat inap dengan menggunakan anastesi, apakah tidak dapat dilakukan di rawat jalan. - Paru - Respiratory Failure tanpa adanya pemeriksaan BGA : meskipun di BA di jelaskan bahwa diagnosa Respiratory failure dapat di tegakan dengan salah satu kriteria akan tetapi saat ini dari BPJS meminta wajib menyertakan hasil BGA dengan hasil sesuai PNPk kasus Respiratory Failure - Pneumonia LOS < 4 hari - Penyakit Dalam - Hypovolemic Syok : Konfirmasi terkait terapi dari hypovolemic syok → loading cairan 1000 cc yang di cantumkan di dalam DRM secara lengkap cara pemberiannya (sesuaikan PNPk) - HIpokalemia : di minta terapi hypokalemia untuk menggunakan intravena, tidak hanya menggunakan terapi oral berupa KSR - Anak - Jaundice dengan bilirubin < 20 mg/dl : di PNPk dapat mendiagnosa Jaundice jika bilirubin > 20 mg/dl - Kasus LOS < 3 hari - Pasien Rujuk dari IGD yang kurang dari 6 jam di RS akan di bayarkan sebagai rawat jalan - Pasien dengan potensi MRS berulang - Diagnosa utama berdasarkan indikasi pasien masuk atau dengan resource terbesar saat pasien MRS
No	Penjelasan :
3	Pokok Bahasan : Obat tertinggal
	Masalah : Banyak pasien yang tidak mengambil obat, sehingga banyak obat tertinggal di farmasiyaitu bulan September 205 pasien, oktober 65 pasien, dan 8 pasien adalah pasien yang sama dibulan sebelumnya. Apabila obat tidak diambil, dan BPJS melakukan konfirmasi berupa telp random ke pasien tertentu untuk crosscheck, maka hal tersebut masuk dalam kategori fraud. Karena di klaim ada tagihan obat, sedangkan pasien menginformasikan bahwa tidak dapat obat. Atau sebaliknya, jika RS menghapus inputan obat di apotik online dan tidak menagihkan obatnya, BPJS juga akan bertanya, kenapa pasien terus dikontrolkan padahal tidak ada obat atau terapi nya.
	Keterangan : obat wajib diambil oleh pasien, karena untuk pasien kronis, sudah terinput di apotik online, dan ikut diklaimkan ke BPJS kesehatan.
	PIC : Farmasi, DPJP, Asisten poli
	Rencana Tindak Lanjut Akan ada data spreadsheet yang akan dibagikan ke asisten poli, agar pada saat pasien tersebut kontrol, DPJP dapat mengingatkan pasien untuk tertib dalam pengambilan obat sambil menunggu fitur “obat tertinggal” di SIMRS Berikut data obat tertinggal sesuai dengan POLI / DPJP :



No	Nama DPJP	Jumlah
1	dr. Nurhadhi Sutanto Sp. M	26
2	dr. Heriyatmo Sp. PD	24
3	dr. Humaira Rahma Sp. OG	15
4	dr. Titok Hariyanto Sp. M	14
5	dr. Dicky Faturrachman Sp.A,M.Biomed	13
6	dr. Antonius Setiadi Sp. B	12
7	Dr. dr. Mohammad Kuntadi Syamsul Hidayat Sp. OT, M.Kes., MMR	10
8	dr. Yoga Waranugraha Sp. JP (K)	10
9	dr. Aida Musyarrofah Sp. OG	9
10	dr. Ardhi Bustami Sp. PD	9
11	dr. Miftakhul Huda Sp. KJ	7
12	dr. Miryanti Cahyaningtias Sp. JP	6
13	dr Fiona Paramitha Sp.A	4
14	dr. Ahmad Farid Wajdi Sp. N	4
15	dr. Zoraida Dwi Wahyuni Sp. PD	4
16	dr. Akhmad Syahrir Sp. N	3
17	dr. Arianto Prabowo Sp. OT	3
18	dr. Dewi Maharani Sp. S	3
19	dr. Pradana Nurhadi Sp. U	3
20	dr. Rossy Zaki Abdillah Sp. B	3
21	drg. Ajeng Poerborani Ditaningtyas Sp.KGA	3
22	dr. Andy Sp. P	2
23	dr. Diah Puspita Rifasanti Sp.M	2
24	dr. Didid Roesono Sp.KJ	2
25	dr. Dwi Nurwulan Pravitasari Sp.KK	2
26	dr. Ira Setya Waty Sp. JP	2
27	dr. Nimim Putri Zahara Sp.THT- KL	2
28	dr. Adya Sitaresmi Sp.DV	1
29	dr. Andi Abdillah Sp.B	1
30	dr. Edi Wibowo Sp.U	1
31	dr. Eko Nugroho Sp. KFR	1
32	dr. Meyrna Heryaning Putri Sp.THT-KL	1
33	dr. Ratih Kusumawardani Sp.A.,M.Biomed	1
34	dr. Sigit Wahyu Jatmiko Sp. BP-RE.,M.M	1
35	drg Ega Lucida Chandra Kumala Sp.Perio	1
No	Penjelasan	
4	Pokok Bahasan : Pasien yang dilakukan PRB harus sudah sesuai kriteria PRB dan apabila ada rujuk internal ke DPJP lain dipastikan juga sudah stabil	
	Masalah : Pasien tidak bisa di PRB karena masih ada kontrol dengan poli lain. Contoh pasien poli IPD, Dx : DM. Pasien sudah bisa di PRB di IPD, akan tetapi pasien ada perawatan dengan dokter jantung Dx : HHD yang masih belum stabil. FKTP tidak bisa menerima pasien yang hanyaselesai salah satu poli, sehingga pasien harus batal PRB dan diarahkan kembali ke RS untuk control kembali ke IPD maupun ke poli jantung.	
	Keterangan : Pasien batal PRB	
	PIC : FKTP, DPJP, Farmasi, Asisten poli	
	Rencana Tindak Lanjut Jika ada pasien yang sudah stabil, harap di PRB kan. Akan ada fitur “rujuk internal”, surat rujuk balik” yang akan mempermudah DPJP untuk melihat riwayat pasien yang dirujuk dari poli lain , sehingga saat akan PRB, DPJP dapat melihat, apakah pasien di poli yang lain sudah stabil ataubelum.	



No	Penjelasan
5	Pokok Bahasan : Foto Rontgen Pre Tindakan dan Post Tindakan
	Masalah : Dari BPJS terdapat kebijakan harus ada foto Rontgen Pre Tindakan dan Post Tindakan untuk pasien orthopedi
	Keterangan : Foto rontgen pre dan post tindakan
	PIC : DPJP, IGD, IKO, Rawat inap
	Rencana Tindak Lanjut : Jika ada pasien fraktur, terutama pasien orthopedi, wajib ada foto rontgen pre dan post tindakan
No	Penjelasan
6	Pokok Bahasan : Pasien dengan kunjungan lama agar di kaji ulang dan menunjukkan indikasi pasien masih di kontrolkan
	Masalah : Pasien dengan kunjungan lama lebih dari 6 bulan atau bahkan 1 tahun lebih, menjadievaluasi dari FKTP dan BPJS, karena akan dipertanyakan apakah pasien belum stabil atau tidak bisa dilakukan PRB.
	Keterangan : Pasien lama di evaluasi apakah bisa di PRB atau di kembalikan ke FKTP
	PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Pasien dengan kunjungan yang sudah lama agar dikaji ulang dan menunjukkan indikasi pasien masih di kontrolkan, apabila pasien sudah di evaluasi dan stabil, maka dpjp bisa mengembalikanpasien untuk melanjutkan pengobatan ke FKTP (PRB)
No	Penjelasan
7	Pokok Bahasan : DPJP cuti
	Masalah : Jika ada DPJP cuti untuk beberapa hari, maka DPJP dapat mengarahkan pasien kontrol ke dokter lain yang dalam satu SMF. Untuk menghindari fraud, tidak diperkenankan jam HFIS dokter yang cuti diisi dengan dokter lain dengan jadwal yang sama. Misal Dokter "X" cuti, digantikan dengan dokter "W" dengan menggunakan billing dan HFIS dokter "X".
	Keterangan : DPJP cuti untuk jangka waktu yang lama
	PIC : DPJP, Pendaftaran, Asisten poli
	Rencana Tindak Lanjut : Penggantian DPJP saat izin, pasien dapat dialihkan pada jadwal SMF yang sama. Jika pasien stabil tetapi masih belum bisa di PRB, dapat menggunakan sistem ITER.
No	Penjelasan
8	Pokok Bahasan : Self Reveral
	Masalah : Pasien yang dilakukan rujukan penuh, dokter perujuk dan dokter penerima rujukan di RS lain adalah dokter yang sama, hal ini menimbulkan potensi audit dari bpjs
	Keterangan : Rujukan ke dokter yang sama di rumah sakit yang berbeda (Self Reveral)
	PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Jika pasien dilakukan rujuk penuh ke RS lain yang kebetulan DPJP nya adalah sama, maka harusditekankan bahwa indikasi rujuk ke RS lain adalah karena keterbatasan alat, obat, penunjang yang memang tidak bisa dilakukan di PHM. Atau di RS lain DPJP tersebut menggunakan Sub spesialis yang tidak ada di PHM. Sehingga jika pasien masih dapat ditangani di PHM, mohon untuk tidak dilakukan rujukan ke RS lain.
No	Penjelasan
9	Pokok Bahasan : Indikasi Rujuk dari Rawat Inap
	Masalah : Feedback dari BPJS mempertanyakan indikasi pasien yang di rujuk di rawat inap dengan alasan pro penanganan lebih lanjut . Contohnya : RS rujukan (RSSA) menanyakankenapa pasien di rujuk dengan keadaan stabil
	Keterangan : Rujuk eksternal



	PIC : Rawat inap, DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Jika ada rujukan eksternal, dilengkapi dengan indikasi medis yang lengkap, tidak hanya membutuhkan penanganan lebih lanjut
No	Penjelasan
10	Pokok Bahasan : Foto klinis pasien operasi
	Masalah : Untuk kasus STT, Batu ginjal dan klinis yang lain, mohon disertakan foto, dan foto tersebut akan didokumentasikan di ERM, sebagai bukti ke BPJS bahwa tindakan yang dilakukan adalah sesuai dengan pemeriksaan klinis.
	Keterangan : foto klinis pasien operasi
	PIC : DPJP, asisten poli
	Rencana Tindak Lanjut Jika ada pasien STT atau kasus dari hasil pemeriksaan klinis yang membutuhkan operasi, diharapkan ada bukti dokumentasi foto, untuk memperkuat bukti apabila ada audit dari bpjs. Untuk teknisnya, bisa dibantu dokumentasi oleh perawat
No	Penjelasan
11	Pokok Bahasan : Pasien TB Paru
	Masalah : Pasien TB paru yang stabil, tidak bisa ditagihkan BPJS karena TB paru adalah program pemerintah yang bisa ditangani di FKTP
	Keterangan : Pasien TB Paru yang stabil
	PIC : DPJP SMF Paru, DPJP SMF Anak
	Rencana Tindak Lanjut Program pemerintah TBC mohon jika stabil bisa di kembalikan ke FKTP (karena tidak di bayarkan oleh BPJS)
No	Penjelasan
12	Pokok Bahasan : Surat Kontrol
	Masalah : Berdasarkan data bulan September 2024, ditemukan surat kontrol yang sama dengan tanggal terbit SEP sebanyak 93 kasus. Dari bpjs, RSPHM di warning karena seharusnya pasien kontrol sesuai dengan jadwal kontrolnya, tidak ada pembuatan surat kontrol saat pasien datang ke RS dengan alasan tidak ada surat kontrol atau tidak dibuatkan oleh poli saat pasien terakhir kunjungan rawat jalan
	Keterangan : surat kontrol harus dikeluarkan setelah pasien selesai periksa di poli rawat jalan
	PIC : PDF, POLI, DPJP, Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut Per 1 November 2024 tidak boleh ada pasien yang berkunjung tidak sesuai dengan jadwal kontrolnya. Sehingga opsinya adalah : 1. Pasien harus diberikan surat kontrol apabila masih dalam perawatan dokter 2. Pasien yang tidak diberikan surat kontrol (stabil), bisa dikembalikan ke FKTP dengan mengisi rujuk balik 3. Pasien yang maju dari jadwal kontrol, bisa diarahkan ke IGD (gawat darurat) atau faskes satu (kondisi tidak emergency) 4. Apabila ada pasien yang mundur dari jadwal kontrol, karena ada kendala / suatu hal, pasien tidak dapat dilayani pada hari tersebut melainkan harus melakukan pengubahan atau edit jadwal di hari berikutnya (H+1)
No	Penjelasan
13	Pokok Bahasan : PRB
	Masalah : Masih ada beberapa kasus pasien PRB yang tidak tercentang PRB di resep, sehingga tidak masuk ke fitur farmasi untuk diterbitkan SRB (Surat Rujuk Balik). Serta tidak dituliskan dengan jelas di surat rujuk balik untuk diagnosis dan terapi yang telah diberikan pada pasien.



	Keterangan : pada rujukan pasien ditulis “PRB”, resep pasien di centang “PRB”, diagnosis dan terapi harus jelas tertulis agar FKTP paham bahwa pasien sudah PRB PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Pasien stabil (dituliskan pada SRB Rujukan dari FKTP untuk diagnosis dan Terapi yang telahdiberikan di rumah sakit disertai dicentang PRB (apabila pasien masuk dalam kriteria PRB)
No	Penjelasan
14	Pokok Bahasan : Penjelasan dari asuransi center
	Masalah : • Iterisasi (dilakukan centang iter diterbitkan surat kontrol untuk jadwal control selanjutnya / diterbitkan SRB apabila pasien surat rujukan telah habis) • Rujuk internal pasien diperlukan konsultasi dan pemeriksaan ke dokter spesialis lain • Pasien dikembalikan ke DPJP utama dengan menerbitkan jawaban atas rujuk internalyang telah diterima (diusulkan ke programmer) Keterangan : Iter, rujuk internal PIC : DPJP, Asisten poli, Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut Mohon untuk dilakukan iter dan rujuk internal sesuai dengan ketentuan.
No	Penjelasan
15	Pokok Bahasan : Diskusi
	Masalah : 1. Berdasarkan SE penerimaan pasien, dan komitmen RS terhadap FKTP, bahwa semua rujukan diterima dulu di IGD untuk di skrining dokter IGD apakah membutuhkan RS Rujukan atau bisa dirawat di PHM dan dikonsulkan ke spesialis 2. Untuk bedah, kasus STT banyak celah untuk pending, maka apakah bisa difasilitasi kamera digital khusus dari RS untuk pendokumentasian klinisnya ? Jawaban : Akan ada pengajuan untuk fasilitas kamera, apakah nanti bentuknya HP atau tablet yang mempermudah dokumentasi STT yang bisa diupload di SIMRS. Akan dibuatkan alur dokumentasi. 3. STT dibagian bawah apakah harus di GA? Jawaban : Dari PHM, masih belum ada kebijakan tersebut. 4. Alasan obat tidak diambil karena pasien menunggu lama di farmasi Jawaban : sudah ada pengantaran obat “primantara” beserta promonya, telpon pasien satu-satu untuk yang obatnya tertinggal, koordinasi dengan mod agar pasien yang tidak mau mengantri, untuk menggunakan aplikasi primantara 5. Kasus jantung valve insufficiency, SMF jantung dan tim KMKB bekerja sama agar tidakterjadi klaim pending yang kedua yang berpotensi tidak dilayakkan. 6. Diagnosis yang diisi dpjp adalah diagnosis klinis, bukan memakai diagnosis coding .karena yang mengcoding adalah dari Asuransi centre 7. Kendala update ERM baru, tampilan CPPT kosong, diagnosis juga kosong tidak default,sehingga harus mengetik ulang, dan anamnesa harus minimal 8 suku kata Jawaban : Berdasarkan rapat kedua RS (PHM dan PHS) dengan PT, maka ada kebijakan update ERM yang tidak ada default dari riwayat sebelumnya, karena ditemukan banyak CPPT yang langsung di submite oleh dpjp dan tidak diubah isiannya, hal ini menimbulkan pertanyaan dari bpjs, karena setiap bulan berkunjung, tetapi isiannya sama dan tidak adaperubahan. Untuk anamnesa minimal 8 suku kata, tujuannya adalah jika ada audit dari bpjs, maka catatan tersebut dapat diserahkan ke bpjs sebagai hasil pemeriksaan saat itu.



	Karena selama ini, beberapa isian anamnesa hanya diisi dengan satu atau dua kata saja, misalnya = 1. Batuk 2. Sesak 3. Panas 4. Batuk pilek Sehingga tidak ada penjelasan berapa hari, batuk berdahak atau batuk kering, maupun batuk yang disertai gejala lain (tidak sesuai dengan kaidah pengisian anamnesa di kedokteran) 8. Dokter IGD baru kalau bisa ada operan atau kamus bersama untuk kasus dan tata laksana awal di IGD, oleh karena bervariasinya cara DPJP melakukan terapi maka di harapkan untuk dokter IGD yang sudah lama dapat memberikan informasi kepada dokter IGD yang baru 9. Adanya beberapa kali case dokter IGD saat konsul tidak menelpon DPJP saat malam hari sehingga penanganan pasien akan menjadi lama → disesuaikan dengan SOP yang sudah ada, jika dalam 3x wa tidak ada balasan mohon dokter IGD segera melakukan telpon kepada DPJP terutama untuk pasien emergency 10. Pasien poli paru tidak ditensi, sehingga jika ttv tidak sesuai, dokter akan kesulitan apakah pasien bisa di PRB atau tidak. Jawaban : Kabid keperawatan koordinasi dengan Karu rawat jalan, untuk mengingatkan asisten perawat poli melakukan pelayanan sesuai SOP (setiap pasien wajib di lakukan TTV) 11. Pasien yang kontak TB paru yang datang ke RS (rujukan dari FKTP) hanya untuk foto rontgen, sedangkan pengobatannya ada di faskes satu. Apakah juga tidak bisa di klaim ? Jawaban : Jika rontgen positif TB dan pasien stabil, pasien bisa dirujuk kembali ke FKTP untuk terapi obat OAT. 12. Pasien di IGD, 2-3 x pasien ikterus, yang tidak terdeteksi di IGD, mohon dokter baru untuk diajari untuk memeriksa pasien termasuk klinis pasien (ikterus) Jawaban : Akan ada supervisi dan monitoring dari kabid maupun ka ins IGD agar hal tersebut tidak terulang 13. Jika DPJP menerima pasien seperti clavus atau ingrown nail bagaimana? Apakah bisa di lakukan di rawat jalan? Jawaban : jika memang ada indikasi lain yang mengharuskan pasien untuk di rujuk ke FKTRL maka bisa di kerjakan di rawat jalan (management RS akan melakukan review tarif tindakan tersebut di atas saat di lakukan di rawat jalan → akan di siapkan untuk ruangan tindakan di rawat jalan)
	Keterangan : Diskusi Komdik
	PIC : Komdik, IGD, IRJA, Kabid, Asuransi center
	Rencana Tindak Lanjut
	Untuk diskusi yang sudah tercantum diatas akan ditindaklanjuti oleh kabid dan unit terkait.

Pemimpin Rapat
Ketua Komite Medik

dr. Arief Heru W, SpAn

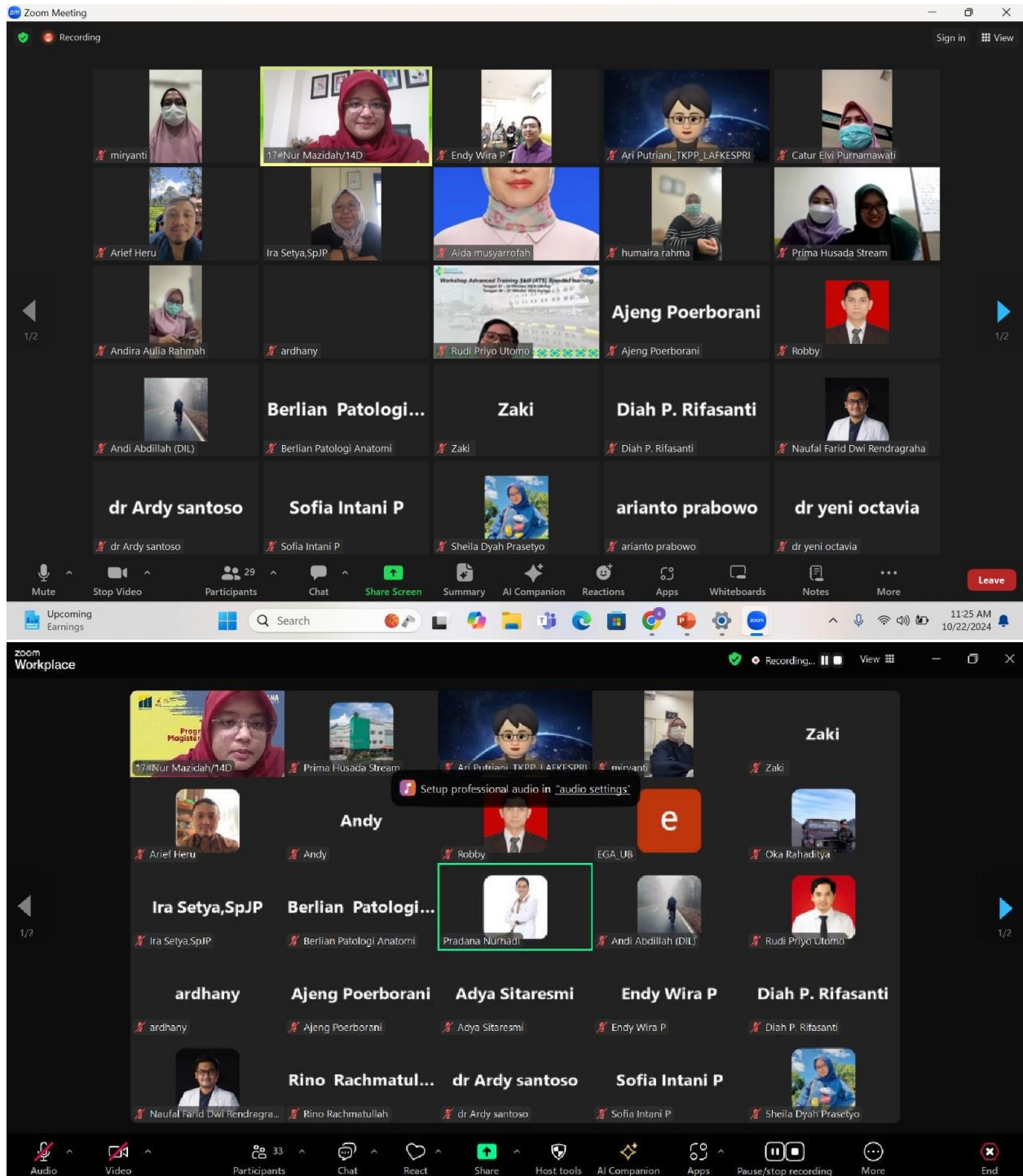
Malang, 22 Oktober 2024
Notulis

Puput Sekar, Amd.Keb, SE

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah

DOKUMENTASI





RSPHMLG
RS PRIMA HUSADA MALANG, SINGOSARI - MALANG
RS PRIMA HUSADA MALANG

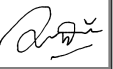
Daftar Hadir
Rapat Komite Medik

Tempat
Location

: Lokasi Dinas Masing- Masing

Tanggal dan : Selasa, 2024-10-22 10:00:00

Jam
Date Time Tue, 2024-10-22 10:00:00

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Mahesa Yudistiranti		administrasi	
2	dr. Miryanti Cahyaningtias, Sp. JP	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah	
3	dr. Eko Nugroho, Sp. KFR	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasibilitas	
4	dr. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG, Sp. OG	RS Prima Husada Sukorejo	Dokter Spesialis Obgyn	
5	dr. Humaira Rahma, Sp. OG	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	
6	dr. Aida Musyarrofah, Sp. OG	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	
7	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp. OT	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatollogi	
8	dr. Andy. Sp. P	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan	
9	dr. Catur Elvi Purnamawati, Sp. P	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan	
10	dr. Ari Putriani, Sp. PK	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Patologi Klinik	
11	dr. Ardhi Bustami, Sp. PD	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	
12	dr Diah Puspita Rifasanti, Sp. M	Poli Mata	DPJP	
13	Very Susanto, S. Kep. Ns	RSPHMLG	Kepala Bidang Keperawatan RSPH Malang	
14	dr. Andira Aulia Rahmah	RSPHMLG	Kepala Instalasi Gawat Darurat RSPH Malang	
15	dr. Arief Heru Wicaksono SpAn TI	RSPHM	Kepala Instalasi Kamar Operasi RSPH Sukorejo	



RSPHMLG
RS PRIMA HUSADA MALANG, SINGOSARI - MALANG
RS PRIMA HUSADA MALANG

Daftar Hadir
Rapat Komite Medik

Tempat
Location

: Lokasi Dinas Masing- Masing

Tanggal dan : Selasa, 2024-10-22 10:00:00

Jam
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
16	Rossy zaki	RSPHSKR	Kepala Instalasi Rawat Jalan RSPH Sukorejo		
17	dr.Ahmad Farid Wajdi.SpN	Phm	Neurologist		
18	dr. Antonius Setiadi, SpB, FINACS	SMF Bedah	PESERTA		
19	dr. Dwi Nurwulan Pravitasari, SpKK	kulit kelamin	PESERTA		
20	dr. Robby, Sp.An-TI	Anestesi	PESERTA		
21	dr. Adya Sitaresmi, Sp.DV	DV	PESERTA		
22	dr Pradana Nurhadi SpU(K)	Urologi	PESERTA		
23	Ega Lucida Chandra Kumala	Poli gigi spesialis	PESERTA		
24	dr yeni octavia	IGD	PESERTA		
25	dr. Nur Mazidah	RS Prima Husada Malang	PESERTA		
26	dr Berlian Anggraeni Putri Sp.PA	Laboratorium Patologi	PESERTA		
27	dr Andi Abdillah SpB FINACS	Bedah	PESERTA		
28	drg ajeng poerborani spkga	gigi anak	PESERTA		
29	dr. Ardityo Rahmat Ardhany, SpPD-KGH	IPD	PESERTA		
30	dr. Naufal Farid Dwi Rendragraha	Dokter Umum IGD	PESERTA		



RSPHMLG
RS PRIMA HUSADA MALANG, SINGOSARI - MALANG
RS PRIMA HUSADA MALANG

Daftar Hadir
Rapat Komite Medik

Tempat
Location

: Lokasi Dinas Masing- Masing

Tanggal dan : Selasa, 2024-10-22 10:00:00

Jam

Tue, 2024-10-22 10:00:00

Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
31	dr. Sheila Dyah Prasetyo	Dokter ruangan	PESERTA		
32	dr. Fachriy Balafif SpBS	bedah saraf	PESERTA		
33	Putri Indah Purnamasari,AMd.Keb	RSPHMLG	PLT Kepala Bidang Penunjang Medik RSPH Malang		

Malang, 23 Oktober 2024

mahesayudistiranti@gmail.com